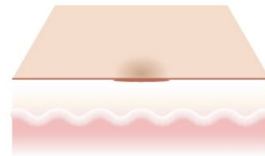


Description des lésions

Non palpable

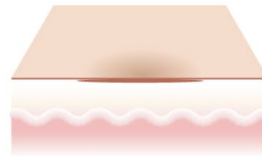
$\leq 1 \text{ cm}$

Macule



$> 1 \text{ cm}$

Patch



Epidermis

Dermis

Palpable

Papule

$\leq 1 \text{ cm}$



Plaque

$> 1 \text{ cm}$

*Epiderme
Dermo superficiel*



Nodule

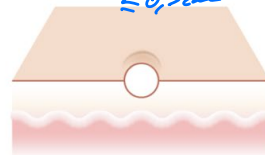
$> 1 \text{ cm}$

+ hypodermis



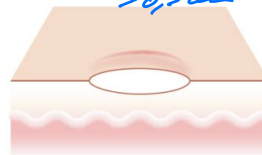
Vesicle

$\leq 0,5 \text{ cm}$



Bulla

$> 0,5 \text{ cm}$



*Surélévation
de l'épiderme*

<https://www.lecturio.com/concepts/primary-skin-lesions/>

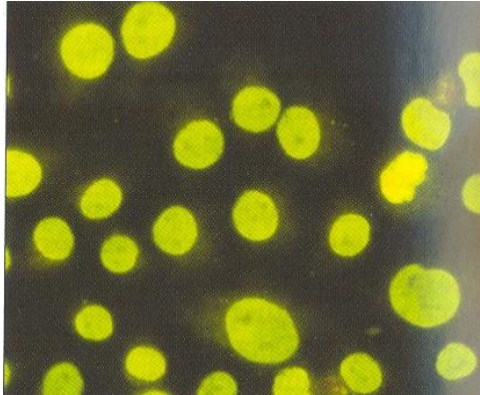
Connectivites : → ANA

2) Distribution des ANA

Coloration homogène des noyaux → Lupus systémique

Homogène:

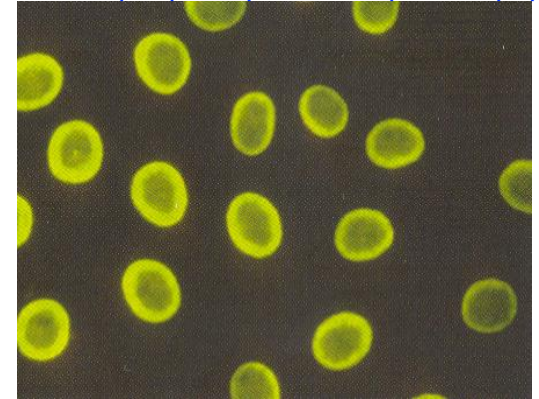
- le moins spécifique
- prédominance dans:
SLE, DLE, maladies rhumatoïdes, âge



Phérophérique:

- prédominance des anticorps anti-ADN;
- Association avec **néphrite lupique**

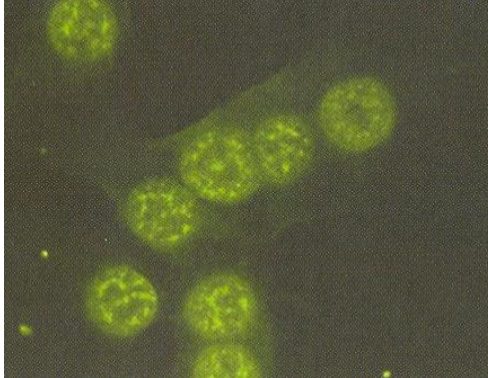
Coloration périphérique → Néphrite lupique



« Moucheté »

- associée à des anti snRNP (gros grains) et SSA/SSB (grains fins)
- MCTD, Sjögren, SCLE**

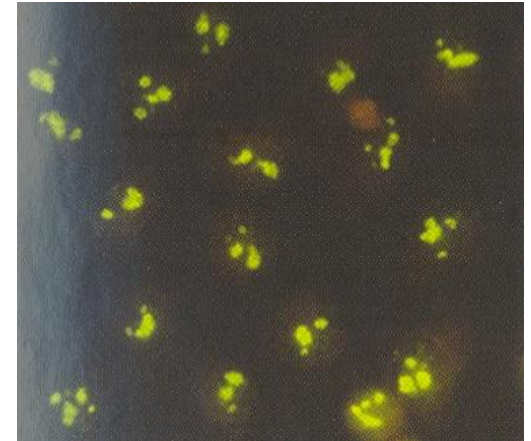
Coloration moucheté → Mixed, Sjögren



Nucléolaire:

- associée avec des anti-Pm/ScI
- caractéristique pour **scléoderma**,

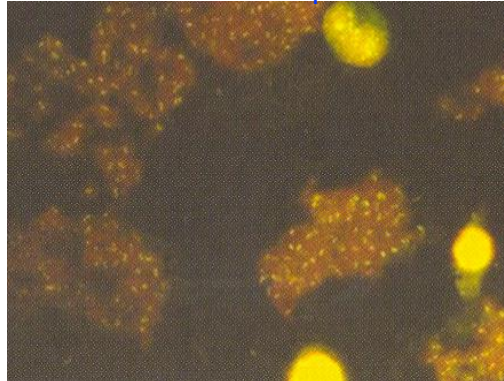
Coloration nucléaire → Scérodermie



Centromérique:

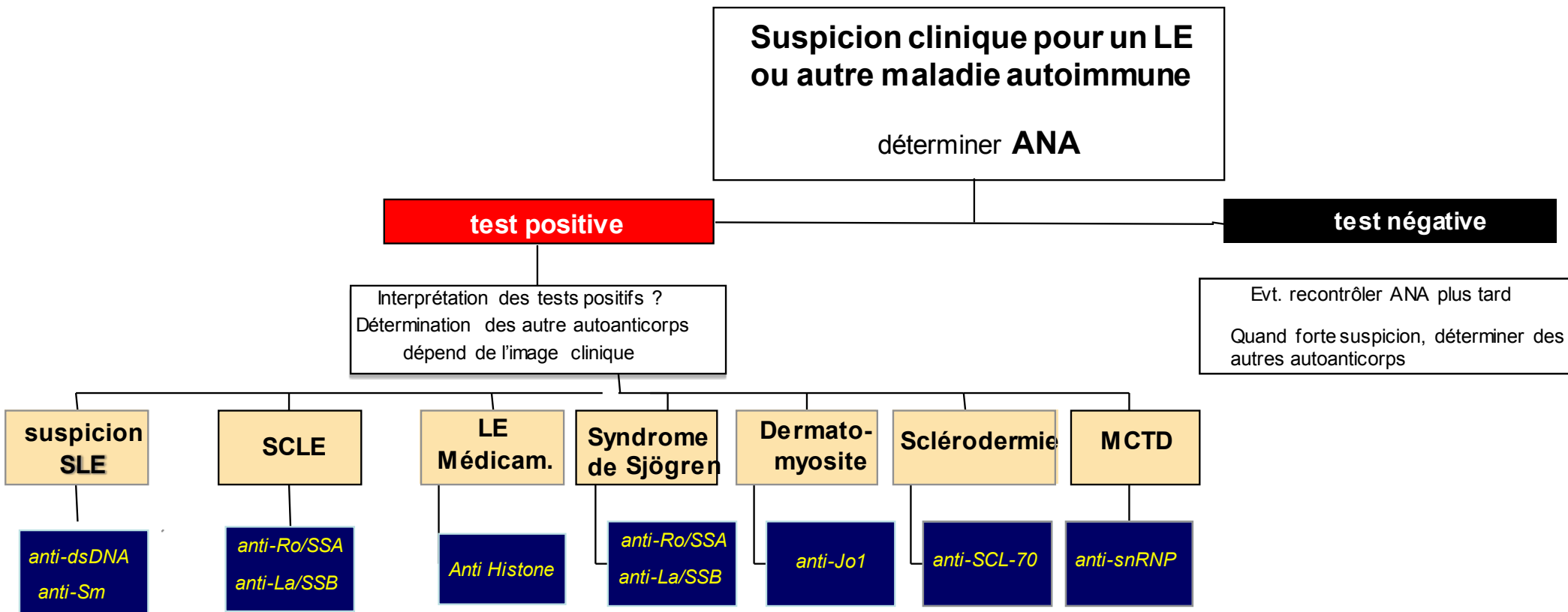
- CREST, scléoderma**

Coloration centromérique → Scérodermie, CREST



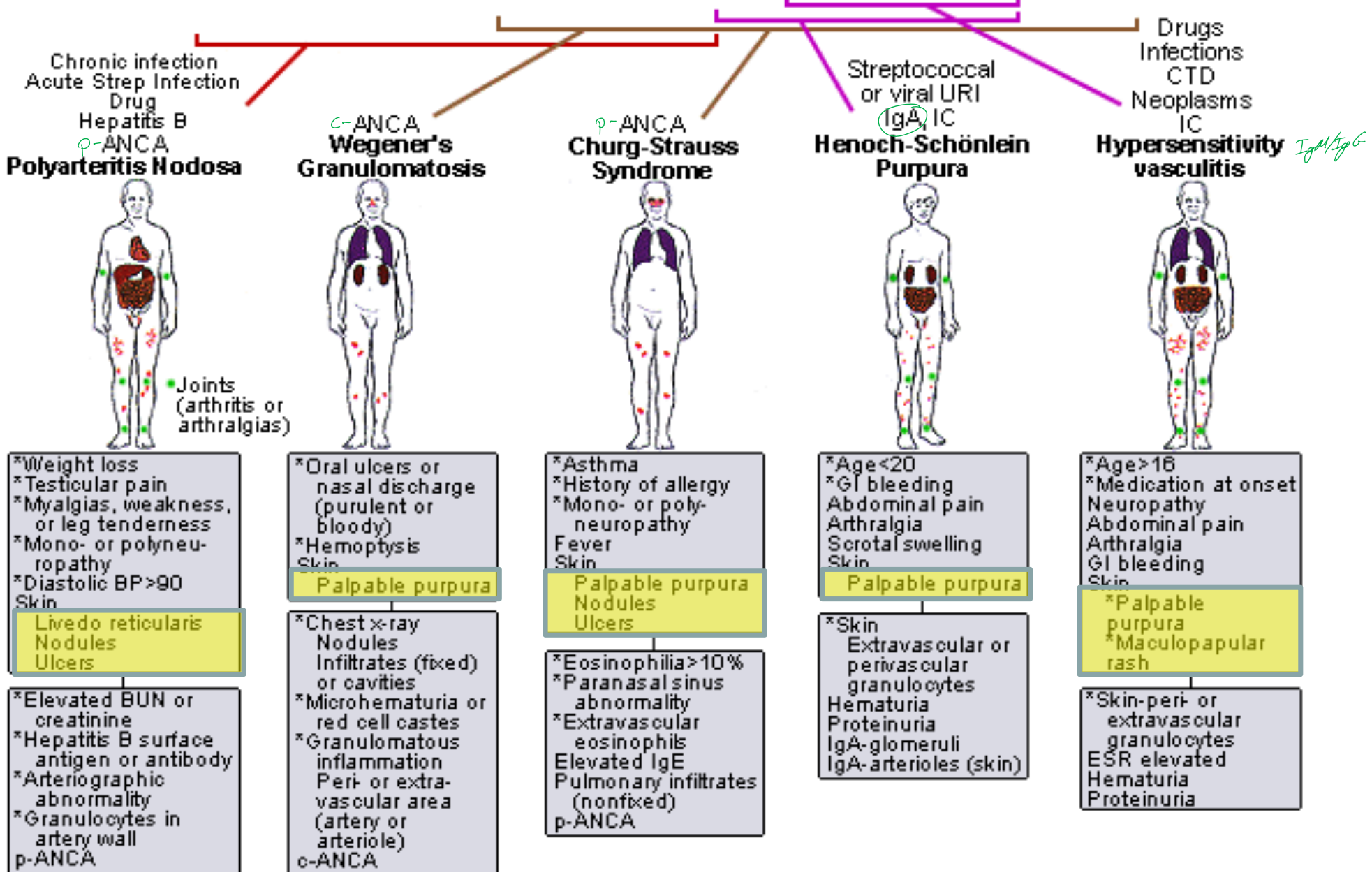
L'immunofluorescence indirecte sur cellules Hep2

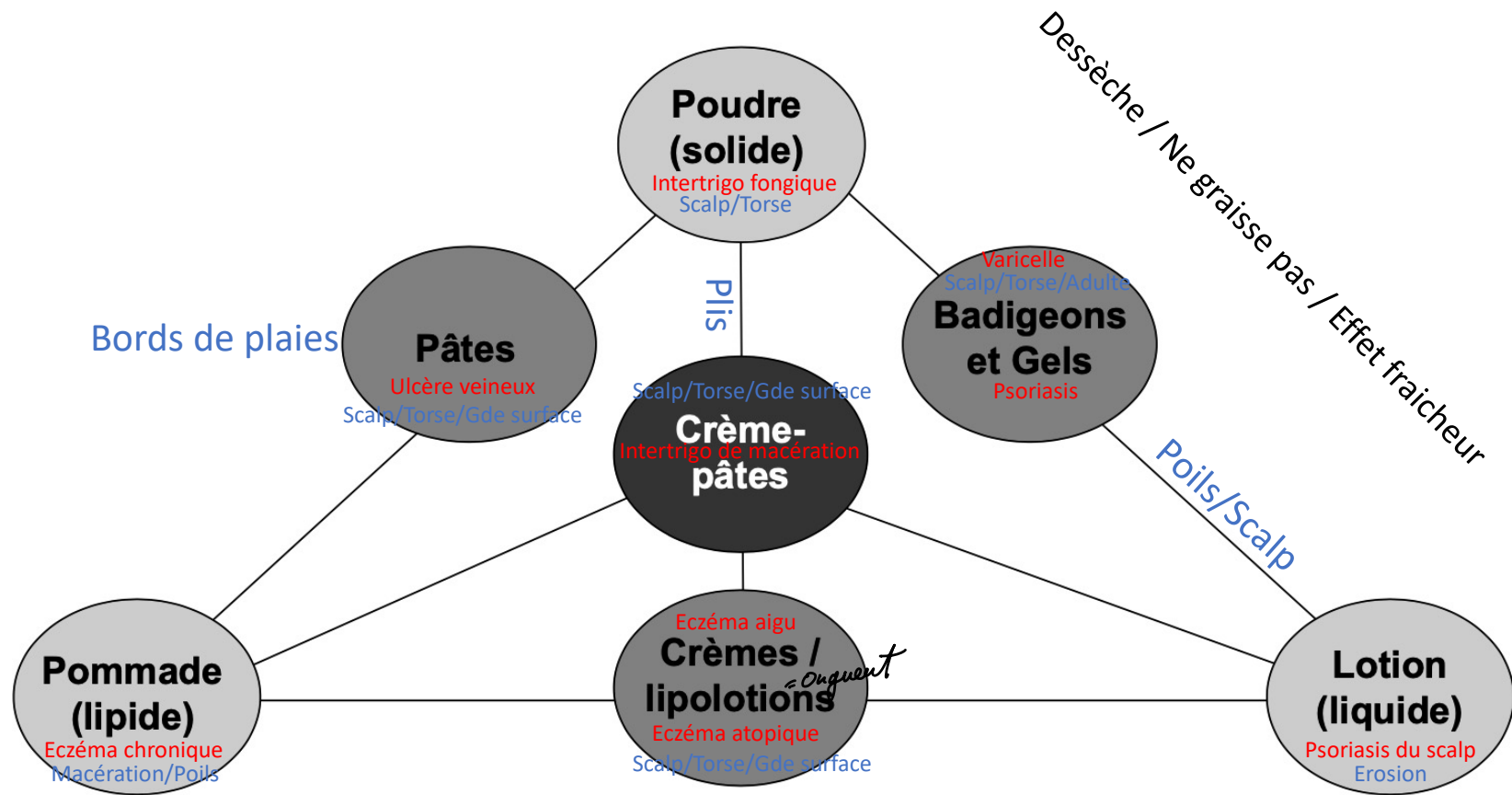
3) Spécificité des ANA



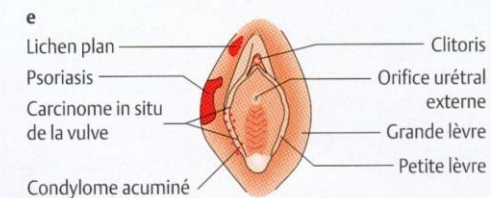
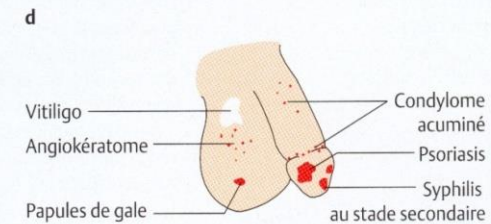
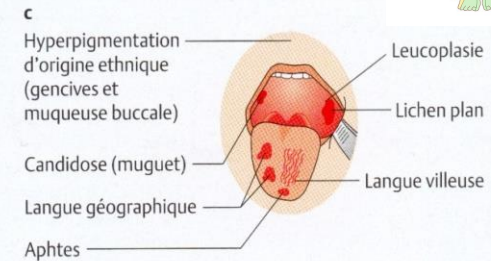
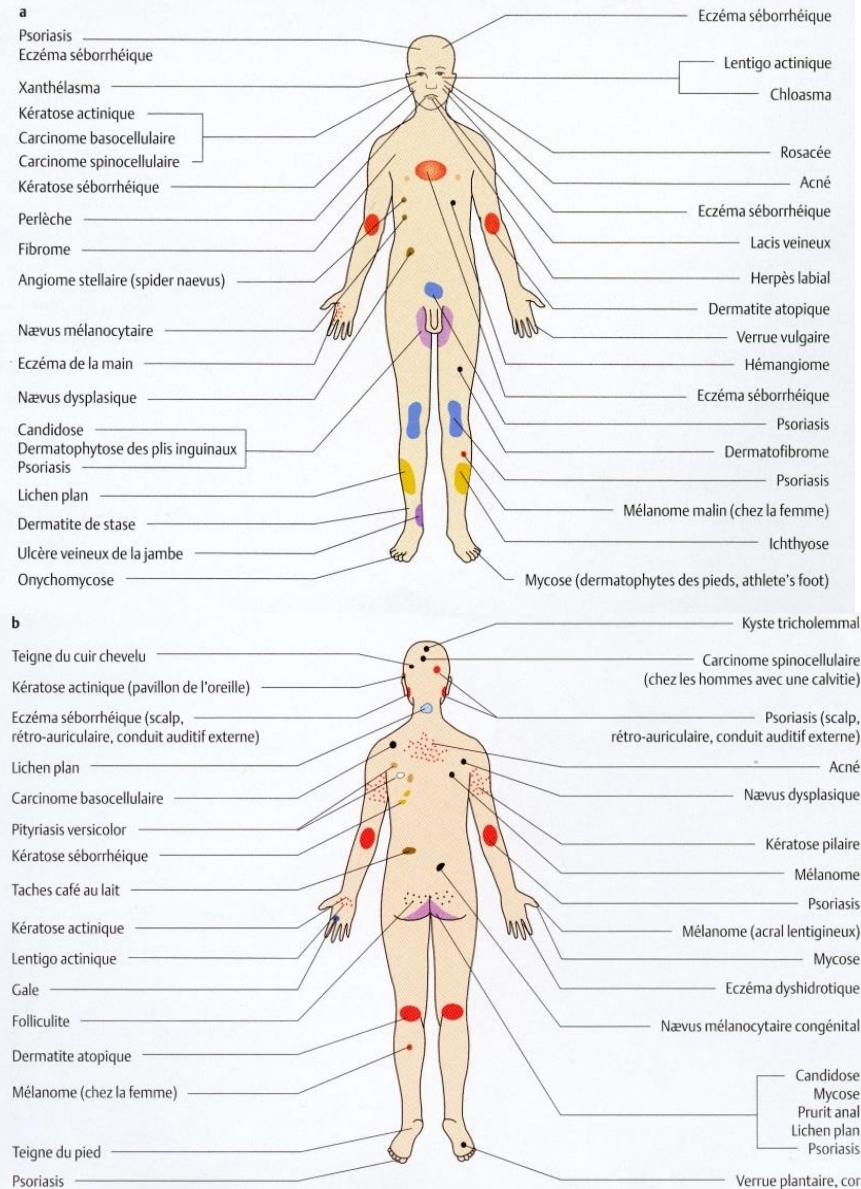
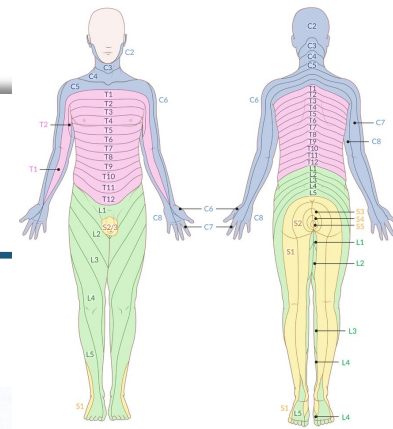
Vasculites: *pANCA*

Large to medium-sized artery	Small artery	Arteriole	Capillary	Venule	Vein
Branches directed to extremities, head, neck Main visceral arteries (renal, hepatic, coronary, mesenteric)	Skin nodules Distal arterial radials (subcutaneous and deep dermal arteries)	Purpura			





Localisation des lésions



7 c-e Lésions fréquentes au niveau buccal, au niveau des organes génitaux masculins et féminins.

GRAIN DE BEAUTÉ (pas inquiétant)

CANCER DE LA PEAU (MÉLANOME) (inquiétant)

A, comme...

Rond, symétrique



...**ASYMÉTRE**

Asymétrique



B, comme...

Régulier



...**BORDS**

Irréguliers



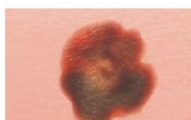
C, comme...

Homogène



...**COULEUR**

Plusieurs couleurs



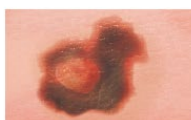
D, comme...

Petit < 6 mm



...**DIAMÈTRE**

> 6 mm



E, comme...

Changement de l'aspect de la lésion : taille, forme, couleur, épaisseur.

...**ÉVOLUTION**



LE **VILAIN** PETIT CANARD
La lésion cutanée différente

<https://www.resopso.fr/2019/06/17/les-mefaits-du-soleil-sur-la-peau/du-soleil-sur-la-peau> - Resopso | Psoriasis



Les lésions élémentaires !

Lésions élémentaires primaires !

Apparaissent au début sans changement de la peau, sans lésion

- **Macule**
- **Papule**
- **Plaque**
- **Nodule**
- **Pustule**
- **Vésicule**
- **Bulle**
- **Urticaire**

Lésions élémentaires secondaires !

Réaction en soit de la peau.

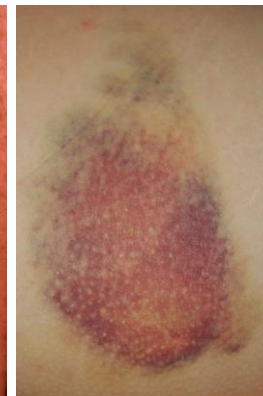
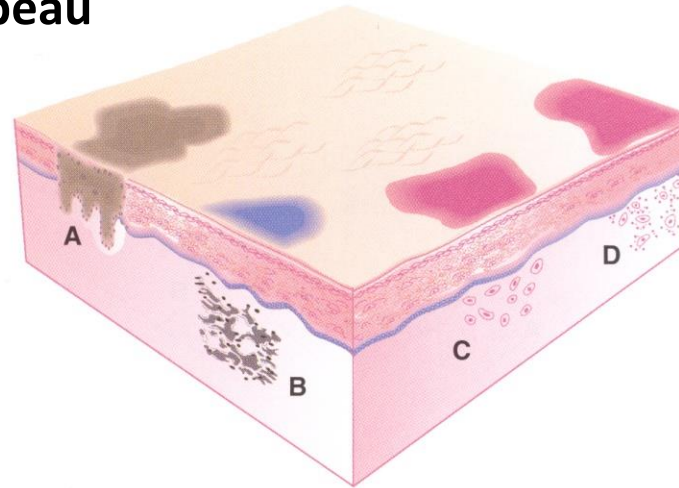
Ne vient jamais seul, toujours une provocation

- **Squame**
- **Croûte**
- **Rhagade, fissure**
- **Érosion**
- **Excoriation**
- **Ulcération**
- **Atrophie**
- **Lichénification**
- **Cicatrice**

Macule !

**Simple modification de la couleur de la peau
sans relief ni infiltration**

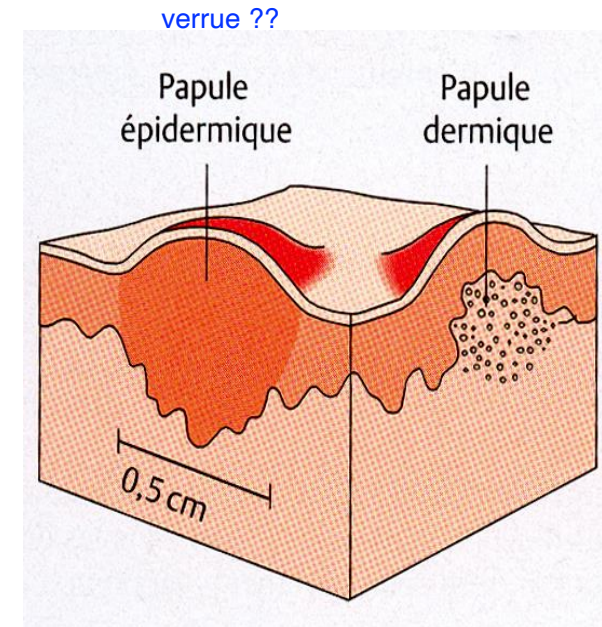
Peut être seulement hyperhémie??



Papule !

Lésion sur-élevée, solide, par augmentation focale de masse du tissu, **<1cm** (0.5cm)

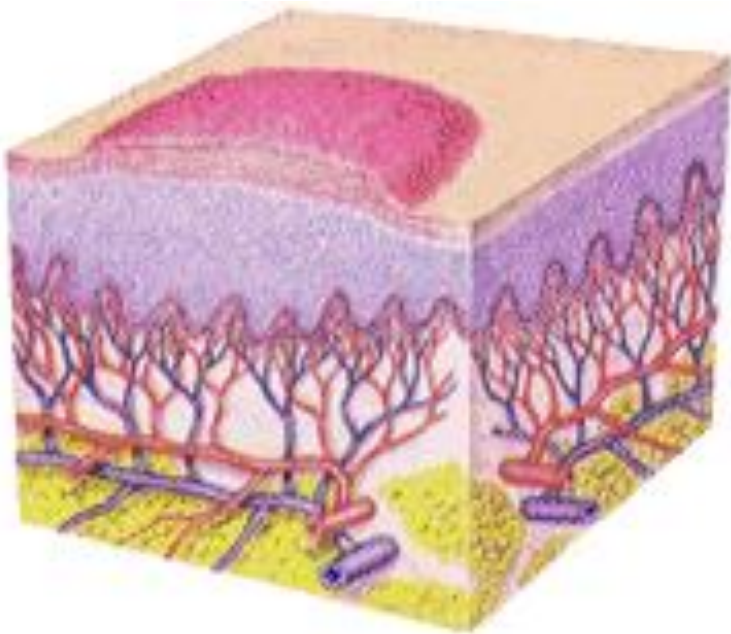
- **Épidermique** (hyperplasie épidermique): limites nettes
- **Dermique** (augmentation de la masse du derme papillaire): limites moins nettes



Plaque !

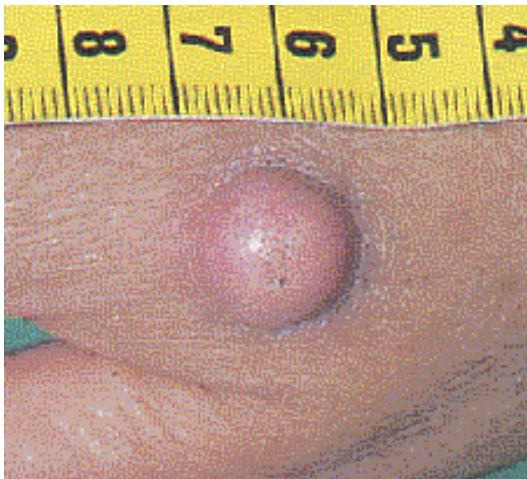
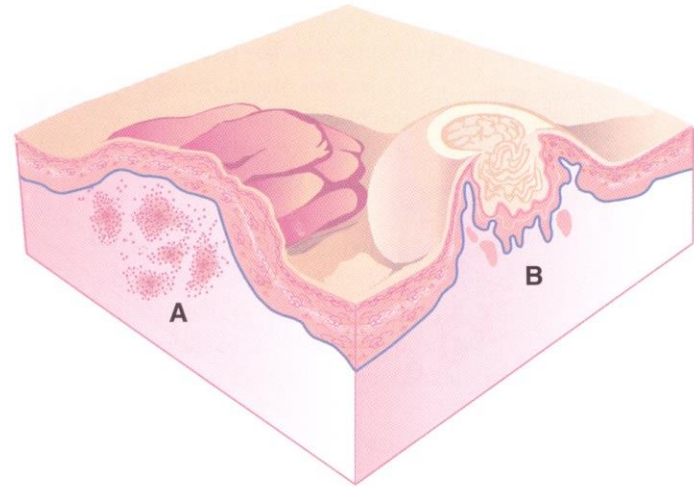
Nodules ou papules confluant —> plus large que haut

Lésion sur-élevée (peau épaissie), solide, >1cm (0.5cm)



Nodule

Masse dermique ou hypodermique,
palpable, avec ou sans élevation, $>1\text{cm}$



Vésicules, Bulles, Pustules !

Elevure circonscrite, contenant des collections liquidiennes

1. Sérosité claire ou hémorragique
 - vésicule <0.5cm
 - bulle >0.5cm
2. Pus
 - pustules

Vésicules et bulles !

Peut être très superficielle, milieu, ou sous-épidermiques

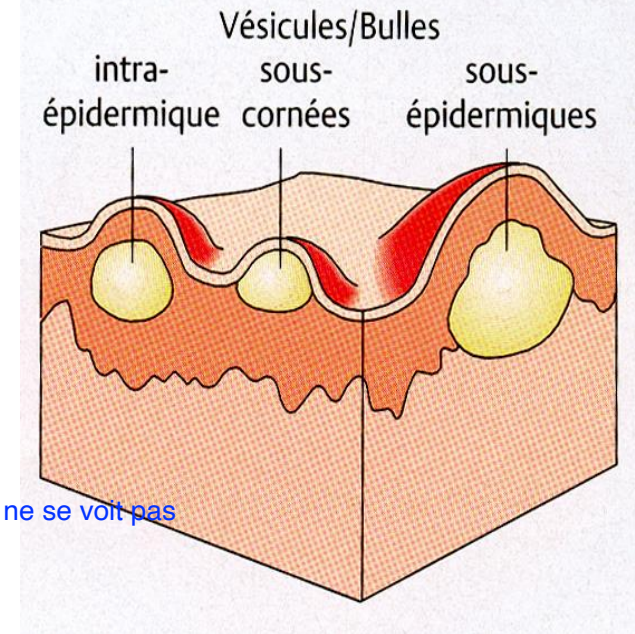
Fragile = se rompt si superficielle ??

Vésicule : élevation circonscrite, contenant une sérosité claire, <0.5cm

Bulle : élevation circonscrite, contenant une sérosité claire, >0.5cm

Fragile : épidermiques → éclate et donc ne se voit pas

Ferme : jonctionnelle



Pustules !

Peut être infectieux

Elevure circonscrite, contenant du pus

- stérile ou non stérile
- folliculaire ou non folliculaire



Urticaire et kyste

Urticaire:

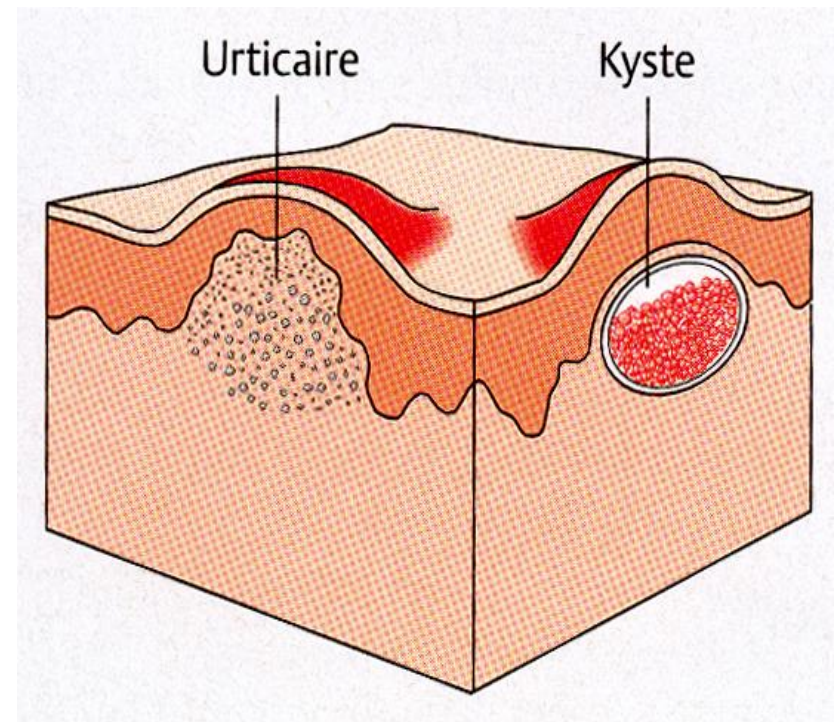
Eruption brutale; prurigineuses

Lésions élémentaires érythémateuses, œdémateuses, bien limitées, en petits éléments (papules) ou confluant en larges plaques qui sont mobiles et fugaces



Kyste:

Une poche ou enveloppe (papule ou nodule), souvent très bien délimitée par rapport aux tissus adjacents, tapissée sur sa face interne d'un épithélium et contenant un matériel de densité variable suivant l'origine du kyste



Urticaire



Les lésions élémentaires !

Lésions élémentaires primaires !

- Macule
- Papule
- Plaque
- Nodule
- Pustule
- Vésicule
- Bulle
- Urticaire

Lésions élémentaires secondaires !

- Squame
- Croûte
- Rhagade, fissure
- Érosion
- Excoriation
- Ulcération
- Atrophie
- Lichénification
- Cicatrice

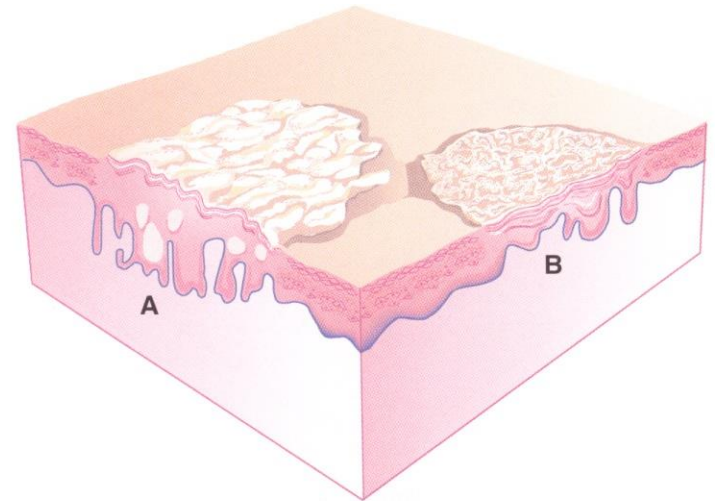
Squame

Lames de couches cornées qui se détachent de la peau
(Desquamation visible), avec ou sans augmentation de l'épaisseur de la couche cornée



L'aspect de la squame peut être spécifique du processus pathologique

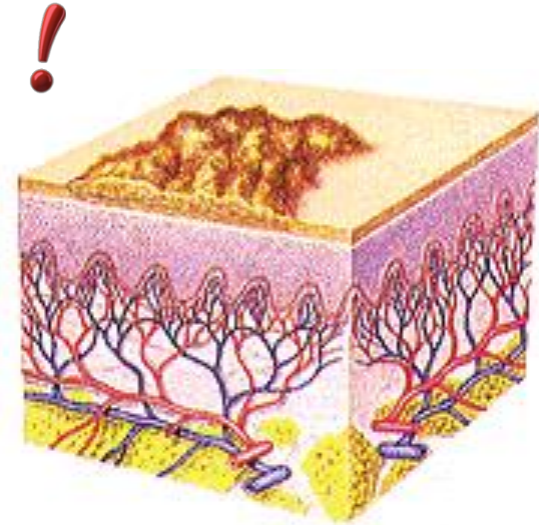
- Psoriasiforme
- Ichtyosiforme
- Pityriasiforme
- etc



Croûtes

Coagulation à la surface de la peau d'un exsudat

- Séreux: à partir de vésicule
- Purulent: à partir de pustule
- Hématique: à partir de plaie



Staphylocoque aureus



Erosion, excoriation, ulcère !

Erosion: épiderme

perte de substance **très superficielle**
(épiderme)

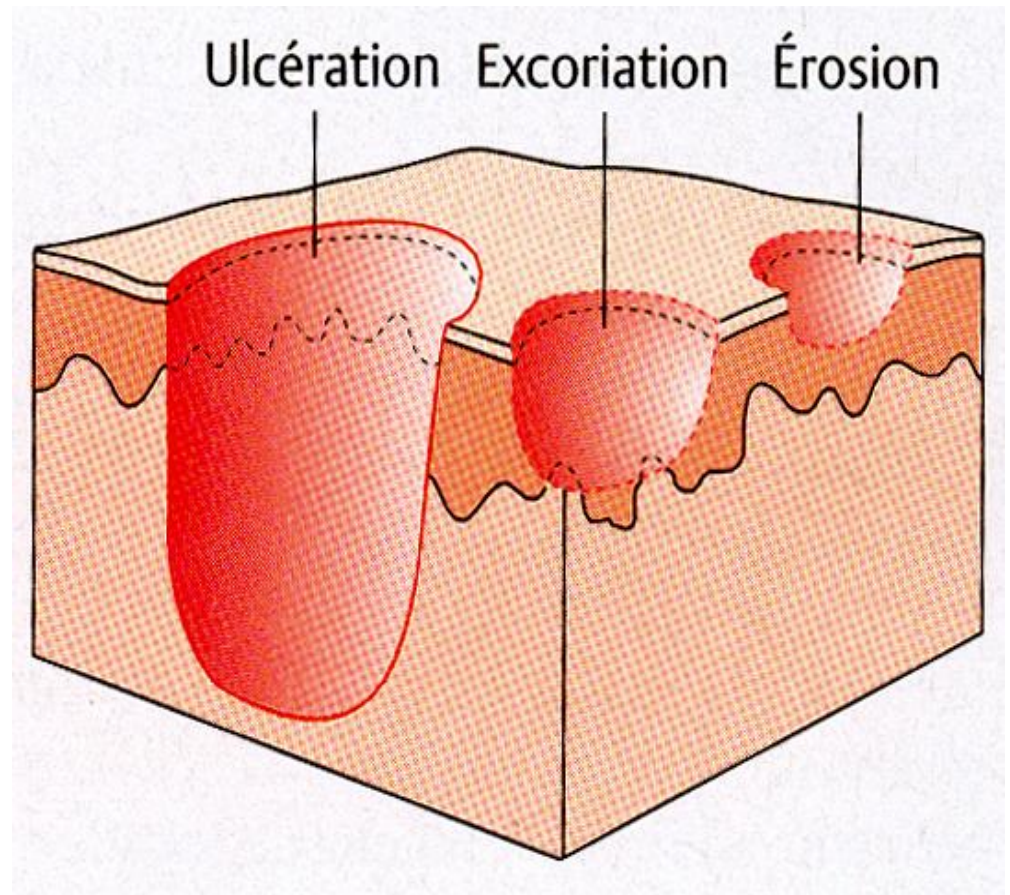
Excoriation: jonction entre épiderme et derme

perte de substance au derme
superficielle

Ulcère: épiderme et derme

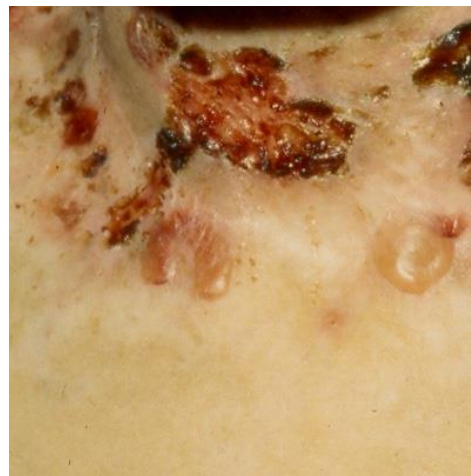
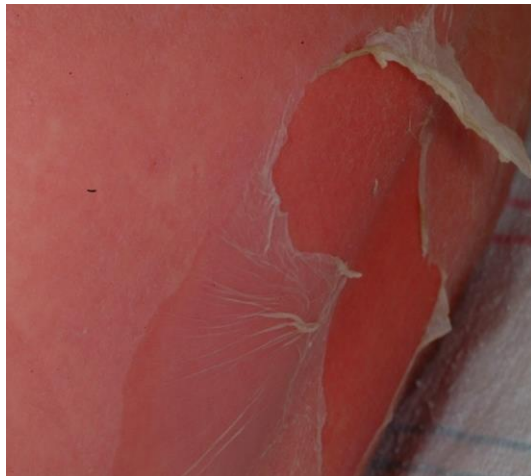
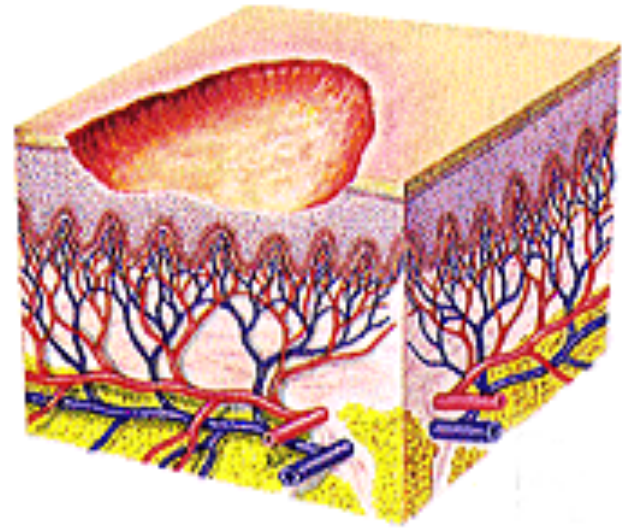
perte de substance superficielle et
profonde (épiderme et derme)

—> tjs une cicatrice



Erosion

- Perte plus ou moins importante de l'épiderme
- Guérison sans cicatrice !



Excoriation

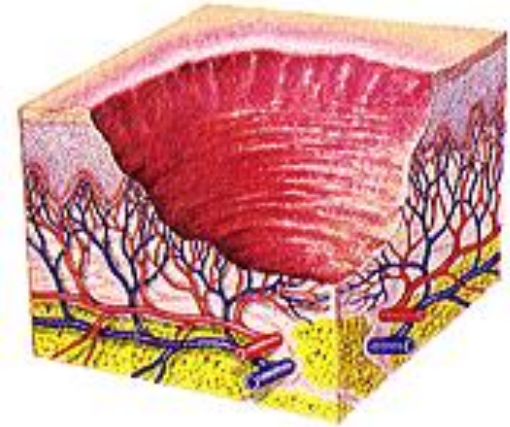


- Perte de toute l'épiderme (jusqu'au derme papillaire)
- Guérison sans cicatrice possible !



Ulcère

- Perte de substance superficielle et profonde
- Guérison avec formation d'une cicatrice



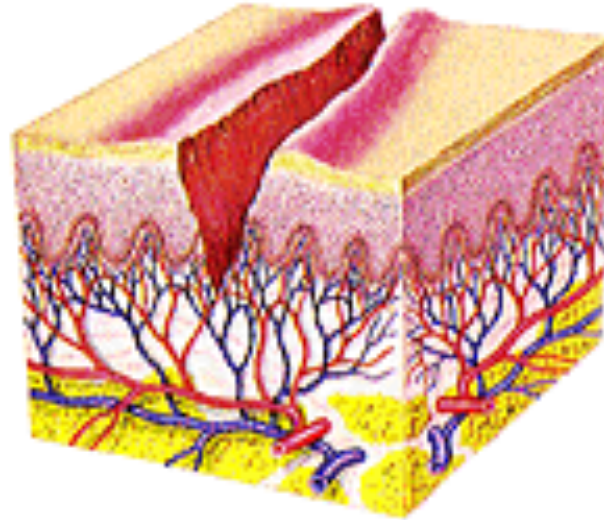
Rhagade, fissure

↳ leures (uniguéuses)

Perte de substance **linéaire**

Peau plus aussi mobile

Très douloureux et prend du temps à guérir

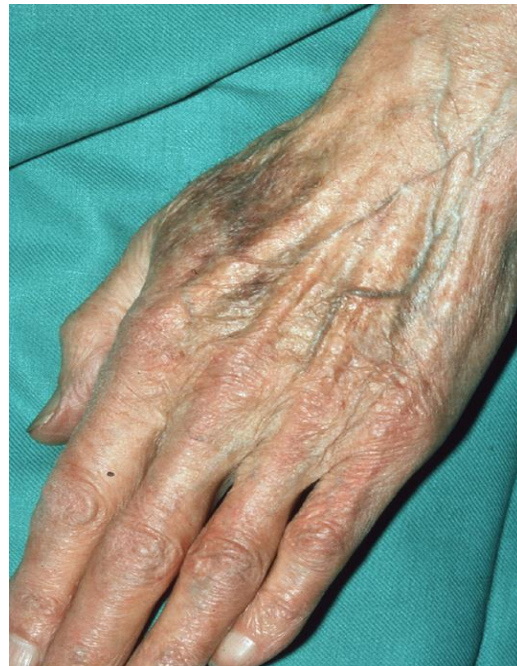


Atrophie

Diminution ou disparition de tout ou partie des éléments constitutifs de la peau (épiderme, derme, hypoderme ou deux voire trois compartiments)



Amincissement de la peau qui de ce fait perd en élasticité et en consistance



Cicatrice

Marque visible et indélébile d'un acte chirurgical ou d'un traumatisme

Cicatrization: la fermeture d'une plaie par un tissu conjonctif fibreux nouvellement formé, ne pas identique au tissu qu'il remplace et habituellement de qualité fonctionnelle inférieure !

- Cicatrice atrophique
- Cicatrice hypertrophique ne dépasse pas la zone du trauma initial
- Chéloïde dépasse la zone du trauma initial

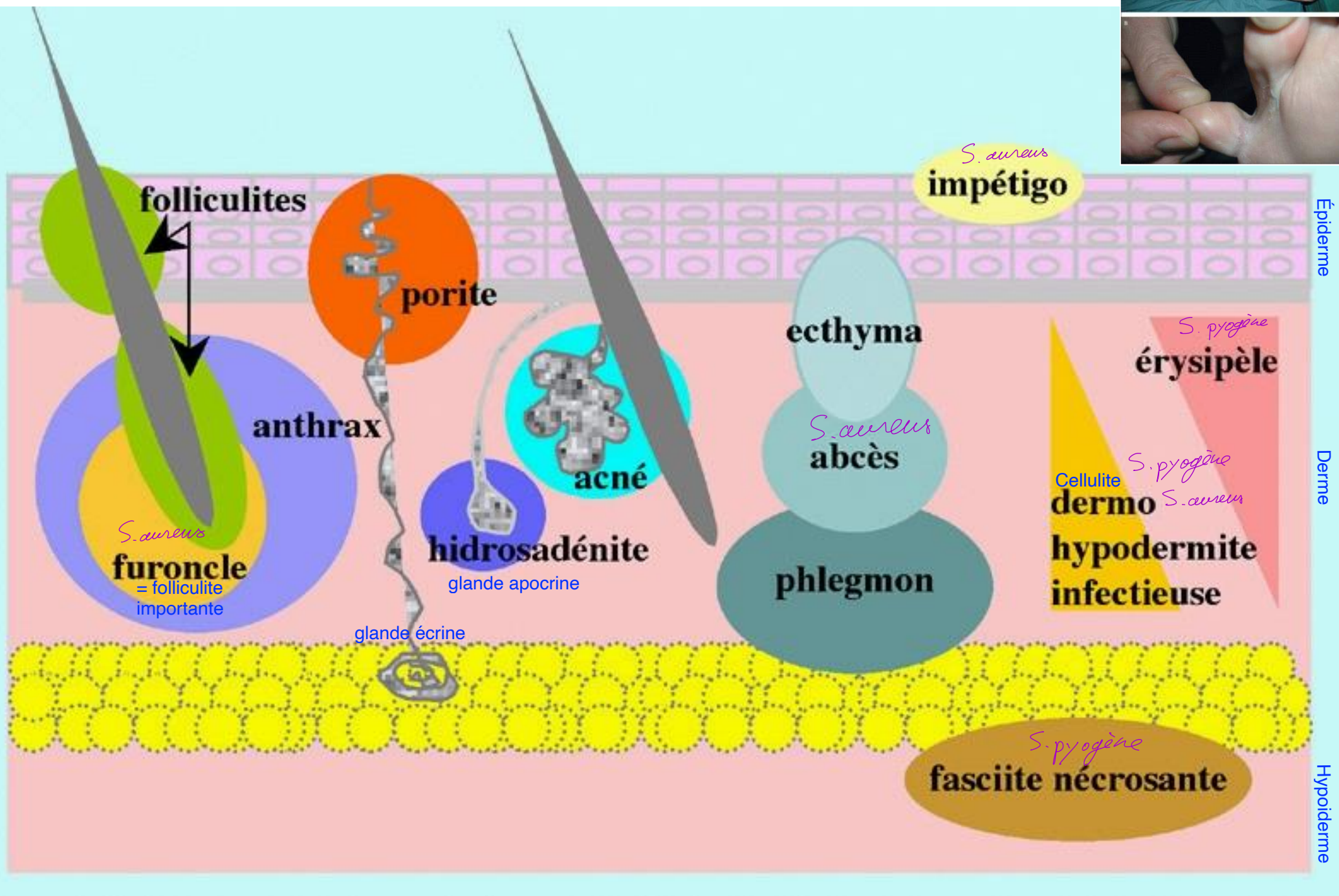


Lichénification

Épaississement de la peau avec accentuation des stries

Etat d'une peau rugueuse et épaisse, recouverte de fines squames dessinant un quadrillage





Inf. superficielle

Erysipèle

→ derme superficiel
Rouge très vif, très bien délimitée, avec petit bourrelet sur le pourtour

Facteurs prédisposants

- Insuffisance veineuse / lymphoedème
- Brèche cutanée (intertrigo, ulcère)
- Obésité

Etiologie

- **Streptococcus pyogenes (gr. A)** (>90%)
- Autres Streptocoques (gr. B, C, G)
- (*Staphylococcus aureus*)

Clinique

Localisation:

- membres inférieurs > visage

Présentation:

- Oedème (léger), rouge (vif)
- Démarcation nette (bourrelet)
- +/- fièvre

Diagnostic: cinique (pas de culture)

Traitement:

- **Pénicilline G ou amoxicilline** (100% sensibilité *S. pyogenes* !)
- Alternative (si allergie): clindamycine
- Durée: 7-10 jours (selon évolution clinique)



Inf. superficielle

Impétigo

Surtout chez enfants (*crèche*)

Très contagieux



Facteurs prédisposants

- Pauvre hygiène
- Grattage

Clinique

Localisation:

- Surtout visage (*zones de grattage*)

Présentation:

- Erythème avec croûtes +/- suintant
- Parfois bulles

Etiologie

- ***Staphylococcus aureus*** (+++)
- *Streptococcus pyogenes* (groupe A)

Traitement

Topique: ^{*=pommade*} mupirocine, acide fucidique
^{*suffisant*}

Systémique (**cas sévère**): amoxicilline-
acide clavulanique *Co-amox.*

Furoncle / Carboncle = amas de puroncles

Inf. superficielle, profonde
Module bien limité, douloureux,
souvent un peu,
au niveau des poils

Facteurs prédisposants

- Portage chronique de *S. aureus* (20-40% population, nez=foyer !)
- Psoriasis, diabète, dysfonction des neutrophiles (Job)...

nécrose purulente du follicule pileux



Etiologie

- *Staphylococcus aureus* (+/- toxine de Panton-Valentin, PVL)
↳ abscess

Traitement:

- Incision / drainage (si ≥ 2 cm)
- Evtl antibiothérapie locale (bacitracine, mupirocine, acide fucidique)
- Antibiothérapie systémique si: signes systémiques (fièvre), cellulite, si patient à risque d'endocardite
Rarement
→ Amoxicilline-clavulanate (Co-aunox.)
→ Alternative: clindamycine (si allergie), co-trimoxazole (si risque MRSA, ex.: USA)

Complications: (- Bactériémie)
- Thrombose septique (nez)

Clinique

Localisation:

- Zones de friction / transpiration / manipulation: nuque, face (nez !), creux axillaire, fesse

Présentation:

- Rougeur localisée, tuméfaction, douleur +/- orifice purulent
- +/- fièvre (rarement)

Diagnostic: clinique (+/- culture)



Inf. superficielle
profonde

Abcès

Facteurs prédisposants

- Toxicomanie iv
- Blessures (dermabrasions)
- Psoriasis, eczéma, diabète, obésité

Etiologie

- **Staphylococcus aureus**
- Streptocoques
- Entérobactéries/anaérobies (périnée)

Clinique

Localisation:

- Zones de friction (fesse), sites d'injection, blessures, *piqûre d'insecte*

Présentation:

- Tuméfaction, rougeur, *voissure* fluctuation et douleur à la palpation
- +/- fièvre, sepsis

Diagnostic: culture, hémoculture (si fièvre)
sur incision / drainage (*bactériémie*)



Traitement:

- Incision / drainage (si ≥ 2 cm), chirurgie (si > 5 cm)
- Antibiothérapie généralement indiquée (débuter avant incision pour éviter bactériémie)
 - Amoxicilline-clavulanate iv ou po → *bactériémie secondaire*
 - Clindamycine (si allergie), co-trimoxazole (si risque MRSA)

Durée: selon évolution

Abcès sur site d'injection avec thrombophlébite



(Complications: - Bactériémie
- Thrombose septique
- Endocardite)

Inf. superficielle
profonde

Cellulite / Dermo-Hypodermite

(ressemble à érysipèle mais moins délimité et plus d'œdème)

Facteurs prédisposants

- Stase veineuse / lymphatique
- Dermabrasion
- Obésité, diabète, OH

Etiologie

- **Streptococcus pyogenes** gr. A
- **Staphylococcus aureus**
- Autres Streptocoques (B, C, G)
- **Morsures chats/chiens: Pasteurella multocida**
- Autres expositions: *Aeromonas hydrophila* (eau douce), *Vibrio vulnificus* (eau salée)...

Traitement:

- **Amoxicilline/clavulanate** (flucloxacilline, céfazoline)
- **Clindamycine** (si allergie). Ajout **ciprofloxacine** si morsure chat/chien (*P. multocida*)
Gram + → *Gram - (Pasteurella)*
- **Débuter en intraveineux pendant 48h-72h** (sauf cas légers)
- **Durée: 7 à 14 jours** selon évolution (moyenne 10 jours)

Complication: **Fasciite nécrosante**

Clinique

Localisation:

- **Membres > visage**
MI > MS

Présentation:

- **Placard érythémateux** (de moins nette que érysipèle)
- **Œdème, chaleur, douleur**
- **+/- fièvre, sepsis**

DD: **dermite de stase, thrombose veineuse** → *US*
Marquer la zone de l'érythème

Diagnostic: **clinique**, hémocultures si fièvre (rarement positives)



Inf. profonde

Fasciite Nécrosante

Facteurs prédisposants

- Dermabrasion, trauma, chirurgie...
- Diabète (gangrène de Fournier)
- Obésité, artériopathie, OH, toxicomanie...

Etiologie

Type I (polymicrobienne)

- Flore mixte (y. c. anaérobies)

Type II (monomicrobienne)

- ***Streptococcus pyogenes* gr. A**
- *Staphylococcus aureus*

Clinique

Localisation:

Type I: membres

Type II: périnée (gangrène de Fournier)
sphère ORL (angine de Ludwig)

Présentation:

- Œdème +++ (sous tension)
- Douleur exquise +/- hypoesthésie
- +/- Rougeur (atteinte profonde)
- Fièvre, choc septique (quasi toujours)

Diagnostic: CT/IRM (svt non conclusif), cultures (tissu), hémocultures (souvent positives)

Clinique précoce essentiel! → Appeler le chir.



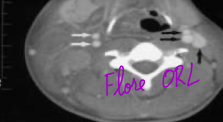
Gangrène de Fournier

Fasciite nécrosante aux niveaux du siège

Flore intestinale

Angine de Ludwig

Fasciite nécrosante aux niveaux du 1. maxillaire



Traitement: Urgent ! (mortalité élevée: 20-60%)

- **Chirurgie (essentielle) !** (reprises, +/- amputation, chirurgie reconstructive)
- Antibiothérapie empirique (large): pipéracilline/tazobactam ou carbapénèmes + vancomycine (MRSA) + clindamycine (effet anti-toxine)
- Puis ciblée: *S. pyogenes* (gr. A) → pénicilline G + clindamycine (anti-toxine).

*Complications: - Choc septique
- Nécrose, gangrène
- Mortalité +++ (20-60%)*